

УДК: 618.19-006.6-089

А.Т. Ермаганбетова, А.К. Дигаи, И.Р. Рутжанулы, Ж.А. Есмагамбетов
ГКП на ПХВ «Онкологический диспансер» г. Астаны

Анализ внедренных интраоперационных способов профилактики лимфореи после хирургического лечения рака молочной железы

Аннотация. Проанализировано влияние интраоперационных способов профилактики на продолжительность и объем лимфореи. В исследование включены 45 больных раком молочной железы после радикальной мастэктомии по Маддену. I группу составили 15 пациенток, которым выполнялась подшивание кожных лоскутов к подлежащим мышцам грудной стенки, во II группу вошли 15 человек, которым выполнялась миопластика подмышечной области, III (контрольная) группа была сформирована из 15 больных после радикальной мастэктомии по Маддену. Показано влияние подшивания кожных лоскутов к подлежащим мышцам грудной стенки и миопластики подмышечной области на объем лимфореи, средний койко-день пребывания в стационаре, время удаления дренажей и продолжительность операции. Установлено, что подшивание кожных лоскутов к подлежащим мышцам грудной стенки уменьшало длительность пребывания пациента в стационаре на 2,6 дня или 15,4 %, сокращало объем лимфы в первые трое суток на 260 мл или 44,9% и снижало время удаления дренажа на 4 дня или 36,7% по сравнению с контрольной группой. Метод миопластики подмышечной области позволил сократить длительность пребывания пациента в стационаре на 2,3 дня или 13,6%, объем лимфы в первые трое суток на 245 мл или 42,3% и снизить время удаления дренажа на 2,6 дня или 23,9%. Средняя продолжительность операции при радикальной мастэктомии (РМЭ) по Маддену с подшиванием кожных лоскутов к подлежащим мышцам грудной стенки составила 112 минут, при РМЭ по Маддену с миопластикой – 103 минут и при РМЭ по Маддену – 100 минут. Применение интраоперационных способов профилактики лимфореи снижают продолжительность, объем лимфореи и сокращают сроки пребывания пациента в стационаре.

Ключевые слова: рак молочной железы, хирургическое лечение, лимфорея.

Актуальность

Проблема лечения рака молочной железы (РМЖ) является одной из главных в клинической онкологии и до настоящего времени остается весьма актуальной. Заболеваемость и смертность от РМЖ у женщин за последние годы продолжают увеличиваться во всех странах мира [1,2,3,4]. Основным методом лечения больных раком молочной железы является хирургический - радикальная резекция молочной железы или мастэктомия в сочетании

с химиолучевым лечением [5,6,8].

Радикальные мастэктомии по поводу РМЖ сопровождаются подмышечно-подключично-подлопаточной лимфаденэктомией, что приводит к пересечению значительного количества приносящих и выносящих лимфатических сосудов от лимфатических узлов данных областей и к образованию полости, размеры которой влияют на частоту послеоперационных осложнений. Чем больше размеры полости, тем больше вероятность развития ранних раневых и поздних осложнений. Вследствие недостаточного прилегания кожных лоскутов к грудной стенке и пересечения значительного числа лимфатических сосудов в ране скапливается серозная и геморрагическая жидкость, что, в свою очередь, способствует формированию лимфоцеле в области послеоперационной раны. Чаще всего лимфоцеле локализуется в подмышечной впадине и несколько реже в области широко отсепарованных кожных лоскутов [7,9,11].

Различные авторы докладывают о частоте развитии лимфореи после радикальной мастэктомии по Маддену у 25%-81% оперированных больных [10,12]. Проблема длительной и обильной лимфореи после радикальной мастэктомии по Маддену остается не решенной. Множество существующих методов профилактики лимфореи свидетельствует о том, что оптимального способа или наиболее эффективной комбинации нескольких способов в настоящий момент нет. Ряд авторов утверждает, что методы интраоперационной профилактики эффективно снижают продолжительность и объем лимфореи почти в два раза [13,14]. Другие исследователи считают, что современные методы профилактики не влияют на продолжительность и объем длительной лимфореи [15,16].

Цель работы

- проанализировать влияние интраоперационных методов профилактики лимфореи на продолжительность, объем лимфореи, а также сроки пребывания пациента в стационаре.

Материал и методы

Проведено исследование 45 пациентов, проходивших лечение в ГКП на ПХВ «Онкологический диспансер» г. Астаны с 2013 по 2014 годы. Все больные были разделены на 3 группы.

В первую группу вошли 15 пациентов раком молочной железы, которым выполнена РМЭ по Маддену с осуществлением закрытия «мертвого» пространства в подмышечной области путем подшивания кожных лоскутов к подлежащим мышцам грудной стенки.

Во вторую группу вошли 15 пациентов раком молочной

железы, которым выполнена РМЭ по Маддену и миопластика подмышечной области малой грудной мышцей. Миопластика выполнялась путем пересечения малой грудной мышцы у места прикрепления к ребрам, далее мышцу отсепааровывали и укрывали на подключичную вену, подшивали к латеральной части клетчатки аксиллярной впадины, тампонируя аксиллярную область. Латеральный кожный лоскут подшивали к боковой поверхности передней грудной стенки.

Контрольная группа состояла из 15-ти пациентов раком молочной железы, которым выполнена классическая РМЭ по Маддену.

Оценена эффективность внедрения данных методов (1 и 2 группы) для снижения продолжительности, объема лимфореи и количества койко-дней пребывания в стационаре.

Результаты и обсуждение

По результатам исследования, установлено, что объем лимфы в первые трое суток в послеоперационном периоде у больных первой группы (подшивания кожного лоскута к подлежащим мышцам грудной стенки) составил 319 мл, во второй группе (миопластика) 334 мл, а в контрольной группе 579 мл (рисунок 1).

Как видно из диаграммы, в первых двух группах существенных различий нет. В то время как в сравнении с группой контроля отмечается снижение объема лимфореи на 245-260 мл, что составило 42,3 – 44,9 %.

Снижение общего объема лимфы позволило удалять дренажи в исследуемых группах раньше, чем в группе контроля. В первой группе (подшивания кожного лоскута к подлежащим мышцам грудной стенки) дренажи удалялись в среднем на 6,9 день, во второй группе (миопластика подмышечной области малой грудной мышцей) дренажи удалялись на 8,3 день. В контрольной группе дренажи удалялись на 10,9 день (рисунок 2).

Также было установлено, что в первой группе, где производилось подшивание кожного лоскута к подлежащим мышцам грудной стенки продолжительность пребывания пациента в стационаре, составила 14,3, по сравнению с 16,9 днями в контроле. Таким образом, внедрение метода подшивания кожного лоскута к подлежащим мышцам грудной стенки позволило снизить продолжительность пребывания больной в стационаре на 2,6 дня, что составило 15,4%. Во второй группе (миопластика) продолжительность средний койко-день пребывания в стационаре составил 14,6. Соответственно, внедрение методики миопластики подмышечной области малой грудной мышцей позволило снизить длительность койко-день пребывания в стационаре на 2,3 дней, что составило 13,6% (рисунок 3).

Однако внедрение новых хирургических методик незначительно увеличило продолжительность операции и составило в среднем, при подшивании кожного лоскута к подлежащим мышцам грудной стенки (1 группа) 112 минут. Во второй группе продолжительность операции составила в среднем 103 минут, тогда как в контрольной группе – 100 минут (рисунок 4).

По нашим данным отмечено, что интраоперационные способы профилактики лимфореи после радикальных операций по поводу рака молочной железы, снижает объем и длительность лимфореи, уменьшает количество дней пребывания пациента в стационаре, сокращают сроки до начала адъювантной терапии, при этом увеличение продолжительности операции незначительно (3-12 минут). По данным литературы также, интраоперационное закрытие "мертвого пространства" в подмышечной области после мастэктомии и подмышечной лимфаденэктомии, путем под-

шивания кожных лоскутов к подлежащим мышцам грудной стенки способствует, уменьшению объема продуцируемой жидкости (с 393 мл до 272 мл) и значительно уменьшению числа сером (с 85% до 25%) (Aitken D.R. et al., 1984). Миопластика подмышечной области малой грудной мышцей является эффективным методом профилактики длительной лимфореи, что приводит к сокращению времени госпитализации, к повышению оборотной и сокращению расходов на лечение (А. Х. Исмаилов и соавт., 2008blh/, Р. Ш. Хасанов, Г. И. Шакирова // Сибирский онкологический журнал : научно-практическое издание. - 2008. - N Прил. 2. - С. 51-52. - ISSN 1814-4861).

Заключение

Таким образом, внедрение новых хирургических методов, таких как подшивание кожного лоскута к подлежащим мышцам грудной стенки и миопластика подмышечной области малой грудной мышцей, позволило уменьшить объем и продолжительность лимфореи, ускорить время удаления дренажей и сократить сроки пребывания пациента в стационаре в среднем на 2,6 дня

Список литературы

- 1 Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ.-М., 2010.
- 2 Schwab M. // Acta Chirurgica Belgica. -, 2008. -Vol. 14.-P. 45- 57.
- 3 Chen W.Y. et al. // Cancer Res. - 2009.
- 4 Билинский Б.Т., Савран В.В. Серомы (лимфорея) после хирургического лечения рака молочной железы // Вопросы онкологии. -1999.- N3 (45). -С. 219-222.
- 5 Харченко В.П., Рожкова Н.И.. Маммология.- М: ГЭОТАР – Медиа, 2009.- 386 с.
- 6 Шевцов А.Ф. Ближайшие местные осложнения радикальной мастэктомии и методы их предупреждения: Автореф. дисс. к.м.н. -Барнаул, 1978. - 18 с.
- 7 Чиссов В.П., Старинский В.В.. Состояние онкологической помощи в России в 2010г.- М., 2011.- 121с.
- 8 Шамилов А.К.Оглы. Комплексная профилактика и лечение послеоперационных раневых осложнений при раке молочной железы (клинико-экспериментальное исследование): автореф. дисс.... д.м.н. - М., 1992. - 36 с.
- 9 Борисов А.П.. Лимфорея как раннее послеоперационное осложнение рака молочной железы // Паллиативная медицина и реабилитация.- 2004. -N4.- С. 62.
- 10 Миланов Н.О.. Постмастэктомический синдром и его хирургическое лечение: автореф....д.м.н. -М., 1984. - 28 с.
- 11 Akinci M., Cetin B., Aslan S. Factors affecting seroma formation after mastectomy with full axillary dissection // Acta Chirurgica Belgica. -2009. -Vol. 109, N 4. -P. 481-3.
- 12 Bohm D., Kubitz A., Lebrecht A. Prospective randomized comparison of conventional instruments and the Harmonic Focus device in breast-conserving therapy for primary breast cancer // European journal of surgical oncology. -2012. -Vol. 38, N 2.- P. 118-24.
- 13 Calogero Cipolla, Salvatore Fracano et al. Does the use of fibrin glue prevent seroma formation after axillary lymphadenectomy for breast cancer. A prospective randomized trial in 159 patients // J. of surgical oncology. - 2010.- Vol. 101. -P. 600-603.
- 14 Ruggiero R., Procaccini E., Gili S. et al. New trends on fibrin glue in seroma after axillary lymphadenectomy for breast cancer // Gionale di chirurgia. -2009. -V.30,N6.-P. 306-10.
- 15 Yilmaz K., Dogan L., Nalbant H. et al. Comparing scalpel, electrocautery and ultrasound dissector effects: the impact on wound complications and pro- inflammatory cytokine levels in wound fluid from mastectomy patients // Journal of breast cancer.- 2011. -Vol. 14,N1.-P. 58-63.
- 16 Aitken D.R., Hunsaker R., James A.O. Prevention of seromas following mastectomy and axillary dissection // Surg. Gynecol. Obstet. - 1984. - Vol.158, N4. - P.327-330.
- 17 Исмаилов А.Х., Хасанов Р.Ш., Шакирова Г.И. // Сибирский

онкологический журнал: научно-практическое издание. - 2008.
- N Прил. 2. - С. 51-52.

Тұжырым

А.Т.Ермаганбетова, А.К. Дигай, Ж.А.Есмаганбетов,
И.Рутжанулы

ГКП на ПХВ «Онкологиялық диспансер» Астана қ.

Сүт безі обырын хирургиялық емдеуден кейінгі лимфореаның
алдын алуды ота үстілік әдістерді енгізуді талдау

Лимфореяның көлемі және ұзақтығы ота үстілік
әдістердің алдын алуының әсер етуі талданып зерттеуге сүт
безі обырына байланысты Мадден әдісі бойынша жасалған
радикалды мастэктомиядан кейінгі 45 науқас алынды, ал
II –ші топқа қолтық асты аймағына миопластика жасалған
15 науқас құрады. Қолтық асты миопластикасы және тері
лоскуттарының кеуде бұлшық еттеріне тігудің әсері –
лимфорея көлеміне, стационарда орташа төсек орын-күн
болуына, бітелерді алу, ота ұзақтығы көрсетілді. Бақылаудағы
топпен салыстырғанда тері лоскуттарын кеуде бұлшық
еттеріне тігу науқастардың стационарда болу ұзақтығының
азайуына 2,6 күн немесе 15,4 %, лимфореаның алғашқы үш күн
тәулік ішінде 260 мл немесе 44,9 % азайуына және біткенің
4 күнге немесе 36,7 % ерте алынуы байқалған. Қолтық асты
аймағының миопластикасы пациенттің стационарда болуы
ұзақтығын 2,3 күнге немесе 13,6 % азайтқан, лимфорея көлемін
алғашқы үш тәулік ішінде 245 мл немесе 42,3 % және біткені
алып тастау уақытын 2,6 күнге немесе 23,9 % азайтқан.
Орташа ота ұзақтығы Мадден әдісі бойынша радикалды
мастэктомия (РМЭ) тері лоскуттарын кеуде бұлшық еттеріне
тігу – 112 минут, Мадден әдісі бойынша РМЭ миопластикамен
– 103 минут және Мадден әдісі бойынша РМЭ – 100 болған. Ота
үстілік лимфореаның алдын алуды қолдану отадан кейінгі
лимфореаның ауырлығын және жиілігін азайтады.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, хирургиялық ем,
лимфорея.

Summary

A.T.Yermaganbetova, A.K.Digai, J.A.Yesmaganbetov, I. Rutjanuli
SCE on PVC “Onkologicheskoy dispensary” Astana

The analysis of the introduced intraoperative methods of lymphor-
rea prevention after surgical treatment of breast cancer

Influence of intraoperative ways of prevention on duration and
lymphorrhea volume is analysed. Research included 45 patients with
breast cancer after a radical Madden's mastectomy. The I group
was made by 15 patients to whom it was carried out an anchoring of
skin rags to subject muscles of a chest wall, the II group included 15
people to whom it was carried out myoplasty of the axillary area,
the III (control) group was created from 15 patients after a radi-
cal Madden's mastectomy. Influence of a anchoring of skin rags to
subject muscles of a chest wall and myoplasty of the axillary area
is shown on lymphorrhea volume, average patient-day of stay in a
hospital, time of removal of drainages and operation duration. It is
established that the anchoring of skin rags to subject muscles of a
chest wall reduced duration of stay of the patient in a hospital for 2,6
days or 15,4%, reduced lymph volume in the first three days by 260
ml or 44,9% and reduced time of removal of a drainage for 4 days or
36,7% in comparison with control group. The method of myoplasty
of the axillary allowed to reduce duration of stay of the patient in a
hospital by 2,3 days or 13,6%, lymph volume in the first three days
on 245 ml or 42,3% and to lower time of removal of a drainage for
2,6 days or 23,9%. The average duration of operation at a radical
Madden's mastectomy (RM) with a anchoring of skin rags to subject
muscles of a chest wall made 112 minutes, at RM by Madden from
the myoplasty – 103 minutes and at RM by Madden – 100 minutes.
Application of intraoperative lymphorrhea prevention methods to
reduce the incidence and severity of postoperative complications.

Keywords: breast cancer; surgical treatment, chylorrhea